

Intervenções baseadas em *evidências* no TEA

Guia prático de **ABA, TEACCH e PBS** para educadores, terapeutas, gestores e famílias — alinhado às diretrizes internacionais (OMS, NICE, AAP, NCAEP) e à legislação brasileira.

 Formato A4 · 30 páginas

 Conteúdo didático com exercícios

 Normas verificadas · jul/2026



IMAGEM DE CAPA — criança e terapeuta em atividade lúdica na mesa, luz natural suave, tons rosa/lilás

Sugestão de busca em banco de imagens: “child therapist playing learning table soft light” (Unsplash · Pexels · Freepik). Ver lista completa em [imagens/SOLICITACAO-DE-IMAGENS.md](#)

— BEM-VINDO

Como usar *este guia*

Este material traduz as principais normas e diretrizes — internacionais e brasileiras — sobre intervenção no Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) em orientações práticas, com exemplos reais de sala de aula e de clínica, exercícios e checklists prontos para usar.

Para quem é

Se você é...	Comece por...
 Educador(a)	Parte 1 (compreender), TEACCH (p. 13–16) e o checklist da p. 26 — para adaptar sua sala e planejar o AEE.
 Terapeuta	ABA (p. 8–12), PBS (p. 17–19) e os parâmetros de qualidade (p. 10) — para basear a intervenção em evidências e documentar bem.
 Gestor(a)	Diretrizes (p. 23), legislação (p. 24–25) e o checklist da p. 27 — para estruturar serviços em conformidade.
 Família	Direitos (p. 24–25), práticas a evitar (p. 22) e o checklist da família (p. 27) — para reconhecer e cobrar qualidade.

Convenções usadas nas páginas

 NA PRÁTICA Como aplicar o conceito no dia a dia real.	 ATENÇÃO Erros comuns, riscos e o que a norma proíbe.
 DICA Atalhos e boas práticas de quem já implementou.	 NORMA O que dizem as diretrizes e a legislação, com a fonte.
 AVISO IMPORTANTE Este guia tem finalidade educativa e não substitui avaliação, diagnóstico ou plano terapêutico individualizado conduzido por profissionais habilitados. Cada criança é única: “ <i>se você conhece uma pessoa com autismo, você conhece uma pessoa com autismo</i> ”. Decisões clínicas e educacionais devem sempre considerar a avaliação individual e a participação da família.	

Ficha técnica

— NAVEGAÇÃO

Sumário

PARTE 1 · COMPREENDER O TEA

- 04** O que é o Transtorno do Espectro do Autismo
- 05** Os três níveis de suporte (DSM-5-TR)
- 06** Sinais precoces e triagem — agir na suspeita
- 07** O que são práticas baseadas em evidências

PARTE 2 · AS TRÊS ABORDAGENS ESTRUTURANTES

- 08** ABA — fundamentos: comportamento tem função
- 09** ABA — o ciclo de trabalho na prática
- 10** ABA — normas, intensidade e qualidade
- 11** ABA — caso prático guiado
- 12** Exercício 1 — identificando funções do comportamento
- 13** TEACCH — fundamentos: a cultura do autismo
- 14** TEACCH — montando o ambiente estruturado
- 15** TEACCH — caso prático guiado
- 16** Exercício 2 — construindo um horário visual
- 17** PBS — fundamentos: prevenção em três camadas
- 18** PBS — o plano de suporte comportamental
- 19** Exercício 3 — verdadeiro ou falso + mini-plano
- 20** ABA × TEACCH × PBS — comparativo e integração

PARTE 3 · O ECOSISTEMA DE EVIDÊNCIAS

- 21** Outras práticas com evidência (NDBI, PECS, CAA...)
- 22** O que evitar — práticas sem evidência ou com risco
- 23** Diretrizes internacionais em uma página

PARTE 4 · DIREITOS E NORMAS NO BRASIL

- 24** As leis que protegem a pessoa com TEA
- 25** SUS, planos de saúde e escola — o que cobrar

PARTE 5 · CAIXA DE FERRAMENTAS

- 26** Checklists — educador e terapeuta
- 27** Checklists — gestor e família
- 28** Gabarito comentado dos exercícios
- 29** Glossário
- 30** Referências verificadas · Sobre o Instituto

PARTE 1

Compreender o TEA

— CAPÍTULO 1

O que é o Transtorno do *Espectro do Autismo*

O TEA é uma condição do **neurodesenvolvimento**, de origem predominantemente genética e multifatorial, que se manifesta desde a primeira infância. Pelo **DSM-5-TR** (APA, 2022), o diagnóstico se apoia em dois domínios:

Domínio A

Déficits persistentes na **comunicação social** e na interação social: reciprocidade socioemocional, comunicação não verbal, relacionamentos.

Domínio B

Padrões **restritos e repetitivos** de comportamento, interesses ou atividades — incluindo hiper ou hiporreatividade sensorial.

Os sinais estão presentes **precocemente**, causam prejuízo significativo e não são melhor explicados por deficiência intelectual isolada. “Espectro” significa que a apresentação varia enormemente: há crianças que falam fluentemente e crianças não verbais; com e sem deficiência intelectual associada; com perfis sensoriais muito distintos.

1 em 31

CRIANÇAS DE 8 ANOS NOS EUA
(CDC/ADDM, DADOS 2022, PUBL.
2025)

~1 em 100

ESTIMATIVA MUNDIAL (OMS, 2023)

3–4 : 1

PROPORÇÃO MENINOS/MENINAS —
COM PROVÁVEL SUBDIAGNÓSTICO
EM MENINAS

 NORMA

No Brasil, a pessoa com TEA é **considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais** (Lei nº 12.764/2012, art. 1º, §2º) — o que aciona todos os direitos da Lei Brasileira de Inclusão (ver p. 24).

 LINGUAGEM IMPORTA

Prefira “**criança com TEA**” ou “**criança autista**” (muitos adultos autistas preferem a segunda forma) e evite termos como “portador”, “sofre de autismo” ou “graus” informais (“autismo leve”). O correto tecnicamente é falar em **níveis de suporte** — tema da próxima página.

— CAPÍTULO 1

Os três *níveis de suporte* (DSM-5-TR)

O DSM-5-TR classifica o TEA pela **quantidade de apoio** que a pessoa necessita — não por “gravidade da pessoa”. O nível orienta o planejamento de intervenções e é avaliado separadamente para cada domínio.

Nível	Comunicação social — como pode aparecer	Comportamentos restritos/repetitivos
Nível 1 “Exige apoio”	Inicia poucas interações; respostas atípicas; dificuldade em fazer amigos apesar do interesse; conversas pouco recíprocas.	Inflexibilidade que interfere no funcionamento; dificuldade em alternar atividades; problemas de organização e planejamento.
Nível 2 “Exige apoio substancial”	Frases simples; interação limitada a interesses restritos; comunicação não verbal claramente atípica mesmo com apoio.	Rituais e comportamentos repetitivos evidentes ao observador casual; sofrimento intenso ao interrompê-los.
Nível 3 “Exige apoio muito substancial”	Fala muito limitada ou ausente; raramente inicia interação; responde apenas a abordagens sociais muito diretas.	Comportamentos interferem acentuadamente em todas as esferas; extrema dificuldade com mudanças.

⚠️ ATENÇÃO

O nível **não é um rótulo fixo**: pode mudar com o desenvolvimento e com intervenção de qualidade, e uma mesma criança pode precisar de mais apoio em um contexto (escola barulhenta) do que em outro (casa). Use o nível para **dimensionar suporte**, nunca para limitar expectativas.



IMAGEM — criança concentrada enfileirando/organizando peças coloridas, vista de cima

Busca sugerida: “child lining up toy blocks top view” (Pexels/Unsplash)

📌 NA PRÁTICA

Ao receber um laudo, procure o nível **por domínio** e as recomendações funcionais. Se o laudo não trazer, peça à equipe avaliadora: é essa informação que converte diagnóstico em plano de intervenção.

— CAPÍTULO 1

Sinais precoces e triagem — *agir na suspeita*

A regra de ouro das diretrizes internacionais: **a intervenção começa na suspeita fundamentada — não se espera o laudo fechado.**

Sinais de alerta por idade

Idade	Sinais que merecem avaliação
Até 12 meses	Não responde ao nome; pouco contato visual; não aponta nem usa gestos (dar tchau, mostrar); não compartilha atenção (olhar junto para algo).
Até 16 meses	Nenhuma palavra funcional.
Até 24 meses	Não combina duas palavras de forma espontânea (sem ser ecolalia).
Qualquer idade	Perda de habilidades já adquiridas (fala, gestos, interação); interesses incomuns e intensos; respostas sensoriais extremas; brincar repetitivo e pouco simbólico.

NORMA — TRIAGEM UNIVERSAL

A **Academia Americana de Pediatria** (Hyman et al., 2020) recomenda triagem específica para TEA aos **18 e 24 meses** (instrumento M-CHAT-R/F) em toda consulta de puericultura, além da vigilância do desenvolvimento em todas as consultas. No Brasil, a Caderneta da Criança traz os marcos do desenvolvimento que fundamentam essa vigilância.

NORMA — SEM LAUDO NÃO SE NEGA APOIO

Na educação, a **Nota Técnica nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE** esclarece: o laudo médico **não é pré-requisito** para o Atendimento Educacional Especializado. A escola não pode condicionar o AEE à apresentação de diagnóstico.

POR QUE A PRESSA?

Nos primeiros anos, a **neuroplasticidade** é máxima: intervenções iniciadas cedo têm efeito maior sobre linguagem, cognição e comportamento adaptativo. Cada mês conta — encaminhe para avaliação e inicie estimulação e orientação familiar em paralelo.

NA PRÁTICA — O QUE O EDUCADOR FAZ

Registre observações objetivas (“não respondeu ao nome em 4 de 5 tentativas”), converse com a família com acolhimento e sem diagnosticar, acione a coordenação e sugira avaliação com pediatra/neuropediatra. Documente tudo no plano da criança.

— CAPÍTULO 2

O que são práticas *baseadas em evidências*

Uma prática é “baseada em evidências” quando estudos científicos controlados e replicados demonstram que ela **funciona para os objetivos a que se propõe**. A referência mais usada na área é a revisão do **NCAEP** (National Clearinghouse on Autism Evidence & Practice; Hume et al., 2021), que analisou 972 estudos e identificou **28 práticas com evidência** para crianças e jovens com TEA — entre elas reforço, dicas e esvanecimento, avaliação funcional, ensino naturalista, vídeo-modelação, PECS e intervenções mediadas por pais.

Evidência não é detalhe burocrático: é o que separa o tempo de desenvolvimento ganho do tempo perdido — e recurso da família bem ou mal investido.

Três perguntas antes de adotar qualquer método

1 Há estudos independentes e replicados?

Não bastam depoimentos ou estudos do próprio criador do método. Procure revisões sistemáticas (NCAEP, NICE, Cochrane).

2 Funciona para *este* objetivo e *esta* criança?

Evidência é específica: um método bom para comunicação pode não servir para seletividade alimentar. O plano parte da avaliação individual.

3 Há monitoramento com dados?

Mesmo a melhor prática precisa provar que está funcionando *para esta criança* — com registro contínuo e critérios de revisão.

Bandeiras vermelhas de pseudociência

- **ALERTA** Promete “cura” ou resultados garantidos e rápidos;
- **ALERTA** Serve “para tudo” — da fala ao intestino — com um único mecanismo;
- **ALERTA** Baseia-se só em depoimentos emocionantes e vídeos de antes/depois;
- **ALERTA** Exige pacotes caros pagos antecipadamente ou exclusividade (“abandone as outras terapias”);
- **ALERTA** Desqualifica quem pede dados (“a ciência ainda não entende nosso método”).

★ **NA PRÁTICA**

Neste guia, as três abordagens estruturantes — **ABA**, **TEACCH** e **PBS** — são apresentadas com suas normas de qualidade. A p. 21 traz outras práticas com evidência, e a p. 22, as que devem ser evitadas.

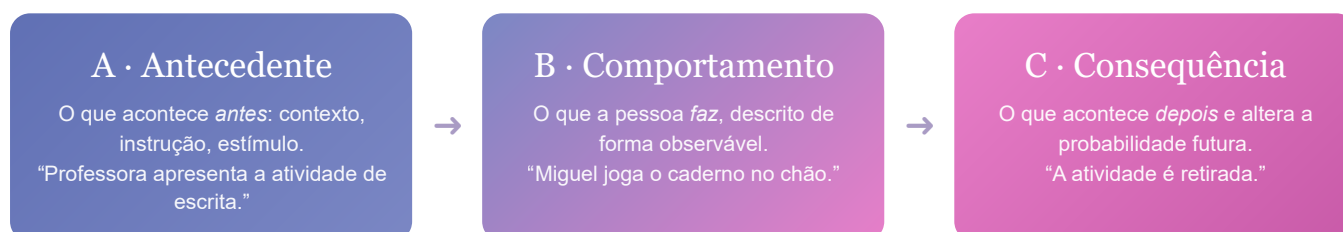
PARTE 2 · ABORDAGEM 1 DE 3

ABA — Análise do Comportamento Aplicada

— ABA · FUNDAMENTOS

Todo comportamento *tem uma função*

AABA é a **ciência que aplica princípios de aprendizagem** para ensinar habilidades socialmente relevantes e reduzir barreiras ao desenvolvimento (Baer, Wolf & Risley, 1968). É a abordagem com **maior corpo de evidências** em TEA e a base técnica da maioria das práticas do NCAEP. Sua unidade básica de análise é a **contingência de três termos**:



Reforço é toda consequência que *umenta* a chance de o comportamento se repetir. No exemplo acima, retirar a atividade **reforça** o jogar o caderno (a criança “escapa” da demanda) — por isso entender a função é o primeiro passo antes de qualquer intervenção.

As quatro funções do comportamento

Função	O comportamento serve para...	Exemplo
Atenção	obter atenção social (mesmo negativa)	Grita e todos olham para ele
Fuga / esquiva	escapar ou adiar demandas e situações	Joga o material e a tarefa é retirada
Acesso a tangíveis	conseguir objeto ou atividade desejada	Chora até receber o tablet
Automática / sensorial	produzir estimulação interna agradável ou aliviar desconforto	Balança o corpo quando o ambiente está barulhento

⚠️ ATENÇÃO

Stimming (autorregulação sensorial) que não machuca nem impede a participação **não é alvo automático de eliminação**. A ética contemporânea (BACB, 2020) exige intervenções que beneficiem a pessoa — não que apenas a façam “parecer típica”.

— ABA · MÉTODO

O ciclo de trabalho *na prática*

- 1 · Avaliar habilidades e prioridades**
Instrumentos padronizados mapeiam repertório e lacunas: **VB-MAPP** (marcos verbais), **ABLLS-R** (habilidades básicas), **Vineland-3** (comportamento adaptativo). A família participa definindo o que é prioridade na vida real.
- 2 · Avaliação funcional (FBA) quando há comportamento-desafio**
Entrevistas + observação com registro A-B-C para formular a **hipótese de função**. Nenhum plano de redução de comportamento deve existir sem FBA (BACB, 2020; APBS).
- 3 · Definir metas socialmente significativas**
Objetivos mensuráveis, funcionais e relevantes para a criança e a família — comunicação, autonomia, brincar, participação escolar. Obtêm-se o **consentimento** dos responsáveis e, sempre que possível, o **assentimento** da criança.
- 4 · Ensinar com procedimentos de evidência**
DTT (tentativas discretas) para habilidades novas em passos pequenos; **NET/ensino naturalista** para generalizar no brincar e na rotina; modelagem, encadeamento, **dicas com esvanecimento** (para não criar dependência do adulto) e reforçamento planejado.
- 5 · Registrar dados em (quase) toda sessão**
Frequência, duração, porcentagem de acertos, nível de dica. Sem dado não há como saber se a criança está aprendendo ou só passando o tempo.
- 6 · Analisar gráficos e decidir**
Progresso estagnado por 2–3 semanas = revisar procedimento, dica ou reforçador. Meta atingida = programar **generalização** (outras pessoas, lugares, materiais) e **manutenção**.

💡 A ABA CONTEMPORÂNEA É (E DEVE SER) GENTIL

Sessões de qualidade se parecem com **brincadeira estruturada**: pareamento (vínculo) antes de demanda, motivação da criança como ponto de partida, zero procedimentos aversivos, atenção a sinais de estresse e ao assentimento. Práticas coercitivas violam o código de ética vigente (BACB, 2020, seções 2.01 e 2.15).

🌟 NA PRÁTICA — PAPEL DA FAMÍLIA

Peça para **assistir a sessões** e receber orientação parental estruturada: intervenções mediadas por pais têm evidência própria (NCAEP, 2021) e multiplicam as horas de aprendizagem no ambiente natural.

— ABA · NORMAS E QUALIDADE

Normas, intensidade e *indicadores de qualidade*

O que dizem as referências internacionais

Fonte (verificada)	O que estabelece
BACB — Ethics Code for Behavior Analysts (2020, vigente desde 2022)	Tratamento eficaz e baseado em evidências; consentimento informado documentado; coleta e uso contínuo de dados ; minimizar riscos e priorizar reforço; supervisão obrigatória e documentada de técnicos.
CASP — Practice Guidelines, 2ª ed. (2020)	Dois formatos: ABA focada (10–25 h/semana, objetivos específicos) e abrangente (26–40 h/semana, múltiplos domínios, típica na primeira infância). Direção clínica por analista qualificado, com supervisão regular do caso e dosagem definida clinicamente — não pelo orçamento.

E no Brasil?

Não há lei federal que regule a profissão de “analista do comportamento”: atuam com ABA psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e pedagogos **com formação específica** (pós-graduação e/ou certificações como BCBA/BCaBA), dentro dos limites do seu conselho. Nos planos de saúde, a **ANS (RN 469/2021 e 539/2022)** garante cobertura da técnica indicada pelo médico — incluindo ABA (p. 25).

Indicadores práticos de um serviço de qualidade

Indicador	Referência
FBA antes de qualquer plano de redução de comportamento	BACB 2020; APBS
Plano escrito, com procedimentos e critérios de revisão	BACB 2020; CASP 2020
Registro de dados na grande maioria das sessões (meta interna sugerida: ≥ 80%)	Boa prática derivada de BACB/CASP
Supervisão do caso frequente e documentada	BACB 2020; CASP 2020
Reunião estruturada com a família (sugestão: quinzenal) com gráficos	Boa prática; participação familiar é exigência ética

⚠ TRANSPARÊNCIA

Valores como “≥ 80% das sessões com dados” são **metas internas de gestão** inspiradas nas diretrizes — o que as normas exigem literalmente é dado contínuo, supervisão e revisão sistemática.

— ABA · CASO PRÁTICO GUIADO

Miguel, 4 anos — *fuga de demanda*

O caso (exemplo didático fictício)

Miguel, 4 anos, TEA nível 2, joga materiais no chão e sai da mesa sempre que atividades dirigidas começam, na clínica e na escola. A equipe decide investigar antes de intervir.

1 FBA — 3 sessões de observação

Registro A-B-C de 12 episódios: 10 ocorreram logo após a apresentação de demanda; em todos, a atividade foi retirada ou adiada. **Hipótese: função de fuga/esquiva.**

2 Prevenção (antecedentes)

Demandas encurtadas e intercaladas com tarefas fáceis (momentum comportamental), **escolha** entre duas atividades e timer visual mostrando quando termina.

3 Ensinar o substituto — comunicação funcional (FCT)

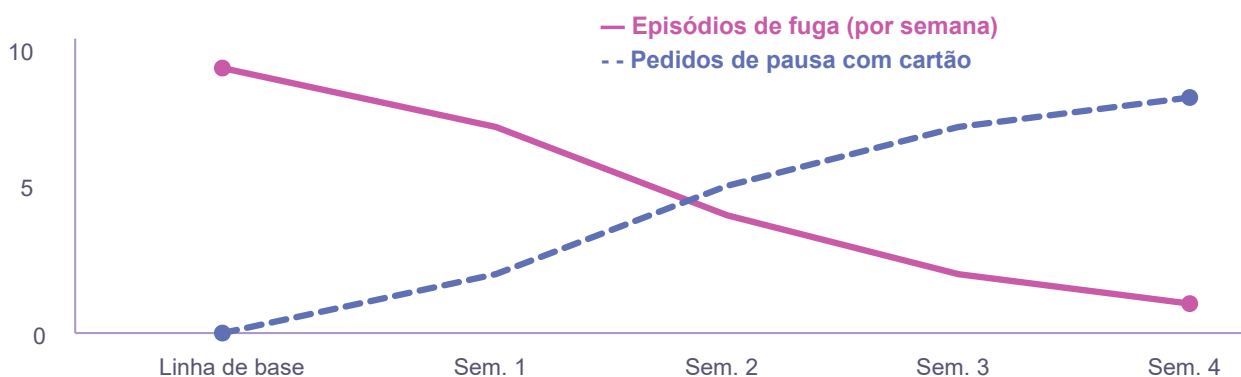
Miguel aprende a entregar um **cartão de “pausa”**: pedir pausa passa a funcionar *melhor* que jogar materiais. A pausa é concedida imediatamente no início.

4 Reforço diferencial (DRA)

Engajamento e permanência são reforçados em intervalos curtos (acesso breve ao brinquedo favorito); jogar materiais deixa de encerrar a atividade — sem broncas, sem forçar fisicamente.

5 Dados e revisão semanal com a família

Frequência diária de episódios e de pedidos de pausa; gráfico revisado semanalmente; escola replica o cartão de pausa na sala.



O QUE ESTE CASO ENSINA

A criança não “parou de fugir por obediência”: ela ganhou um **jeito melhor de comunicar** a mesma necessidade — e o ambiente parou de premiar a fuga sem perceber. Função compreendida = intervenção respeitosa e eficaz.

— ABA · FIXAÇÃO

Exercício 1 — *qual é a função?*

EXERCÍCIO 1

Identificando funções do comportamento

Para cada cenário, escreva no parêntese o código da função mais provável e **sublinhe no texto a consequência** que sustenta sua hipótese. Gabarito comentado na p. 28.

A · ATENÇÃO

F · FUGA/ESQUIVA

T · ACESSO A TANGÍVEL

S · AUTOMÁTICA/SENSORIAL

1. Lara, 3 anos

Função: ()

No mercado, a mãe diz “hoje não” para o chocolate. Lara grita e se joga no chão; após alguns minutos, recebe o chocolate “só hoje, para sair logo”.

2. Théo, 6 anos

Função: ()

Quando a professora distribui a lição de escrita, Théo derruba os lápis e deita no chão. É levado para “se acalmar” no pátio — e a lição fica para depois.

3. Bia, 8 anos

Função: ()

Bia emite sons altos sempre que a professora se dedica a outros alunos. A professora interrompe o que faz e vem conversar (“Bia, assim não pode...”). Os sons aumentaram nas últimas semanas.

4. Rafa, 5 anos

Função: ()

Na festa da escola, com música alta, Rafa balança as mãos e o corpo repetidamente, sorrindo, mesmo quando ninguém está por perto.

5. Monte o A-B-C

“Durante a escovação de dentes, Nina morde a escova e vira o rosto; a mãe desiste e encerra a escovação.”

Preencha:

A — Antecedente:

B — Comportamento:

C — Consequência e função provável:

PARTE 2 · ABORDAGEM 2 DE 3

TEACCH — Ensino Estruturado

— TEACCH · FUNDAMENTOS

Organizar o mundo para a “cultura do autismo”

O **TEACCH** (Universidade da Carolina do Norte, fundado por Eric Schopler em 1972) parte de uma ideia poderosa: em vez de exigir que a criança se adapte a um ambiente confuso, **estruturamos o ambiente** para que ele faça sentido para o cérebro autista. O método atual chama-se *Structured TEACCHing*.

O que a “cultura do autismo” valoriza

Forças típicas

- **Processamento visual** forte — ver é mais claro que ouvir;
- Memória excelente para **rotinas e detalhes**;
- Interesses intensos que **motivam** a aprendizagem;
- Preferência por **previsibilidade** e regras claras.

Desafios frequentes

- Linguagem falada rápida e abstrata;
- Sequenciar etapas (“o que vem depois?”);
- Transições e mudanças inesperadas;
- Filtrar estímulos irrelevantes (ruído, poluição visual).

Os quatro componentes do Ensino Estruturado

Componente	Responde à pergunta...
1 · Estrutura física	“Onde as coisas acontecem?” — áreas delimitadas com função clara (trabalhar, brincar, acalmar), menos distratores.
2 · Horário visual	“O que vai acontecer hoje — e em que ordem?” — sequência de objetos, fotos, pictogramas ou palavras.
3 · Sistema de trabalho	“O que fazer, quanto, quando termina e o que vem depois?” — organização esquerda→direita, caixa de “pronto”.
4 · Estrutura visual da tarefa	“Como fazer?” — a própria atividade mostra visualmente onde começar e o que é esperado (gabaritos, contornos, modelos).

 EVIDÊNCIA

Revisões clínicas (AAP, 2020) classificam o TEACCH com evidência **moderada** — com bons resultados em engajamento, independência e redução de estresse em transições. É especialmente valioso para **nível 3**, mas beneficia todos os níveis e combina perfeitamente com ABA e CAA.

— TEACCH · MÉTODO

Montando o *ambiente estruturado*



1 Delimite áreas com função única

Estantes, tapetes e fita no chão “desenham” onde cada coisa acontece. O corpo aprende o mapa antes da linguagem.

2 Reduza o ruído visual e sonoro

Paredes perto do trabalho quase vazias; materiais fora de uso ficam fechados. Decoração vai para longe das áreas de concentração.

3 Horário visual na altura dos olhos

Escolha o nível simbólico certo: **objeto real** → **foto** → **pictograma** → **palavra**. A criança manipula o horário (retira o cartão concluído ou marca “feito”).

4 Sistema de trabalho esquerda→direita

Tarefas na bandeja esquerda, execução ao centro, caixa de “**pronto**” à direita — e um cartão mostrando o que vem depois (de preferência algo bom).

5 Anticipe as transições

Timer visual + aviso prévio (“mais 2 minutos”) + cartão da próxima atividade reduzem a maioria das crises de mudança.



IMAGEM — sala de aula estruturada real com horário visual de pictogramas na parede

Busca: “classroom visual schedule autism structured” (Freepik/Adobe Stock) — ou foto da própria sala do Instituto (com autorização de imagem)

— TEACCH · CASO PRÁTICO GUIADO

Davi, 7 anos — *previsibilidade que acalma*

O caso (exemplo didático fictício)

Davi, 7 anos, TEA nível 3, não verbal, gritava e se jogava no chão em quase toda transição na escola. A equipe percebeu que ele nunca sabia *o que vinha depois* — cada mudança era um susto.

1 Rotina visual mínima viável

Começaram com **3 fotos reais** (atividade → lanche → parque) num suporte vertical na mesa. Nível simbólico testado antes: Davi reconhecia fotos, ainda não pictogramas.

2 Ambiente reorganizado

Mesa de trabalho voltada para área neutra (sem porta/janela no campo visual), material da vez na bandeja esquerda, caixa de “pronto” à direita, reforçador visível na foto seguinte.

3 Transição com objeto de referência

Timer visual de 2 minutos + cartão-foto entregue na mão de Davi para levar até a próxima área — o corpo participa da mudança, em vez de ser “puxado”.

4 Expansão gradual

Em 6 semanas, a rotina cresceu para o período completo (6 quadros) e Davi passou a **retirar sozinho** o cartão concluído. As crises de transição caíram para episódios isolados.

5 Generalização para casa

Os pais montaram rotina matinal com as mesmas fotos (acordar → banheiro → café → uniforme). A previsibilidade virou linguagem comum entre escola e família.

TEACCH + CAA ANDAM JUNTOS

Estrutura visual organiza o ambiente; a **Comunicação Aumentativa e Alternativa** (prancha, PECS, dispositivo com voz) dá voz à criança dentro dele. Um não substitui o outro — Davi começou o PECS no mesmo período (ver p. 21).

ERRO COMUM

Montar o horário visual **e não usá-lo**: cartaz parado na parede não é rotina visual. A criança precisa consultar, manipular e ver o horário mudar quando o dia muda — inclusive com o cartão “surpresa” para imprevistos.

— TEACCH · MÃO NA MASSA

Exercício 2 — *construa um horário visual*

EXERCÍCIO 2

Planejando a manhã de um aluno

Cenário: João, 5 anos, nível 2, entende fotos e alguns pictogramas. A manhã escolar tem: chegada, roda de conversa, atividade na mesa, lanche, parque e saída. Ele tem dificuldade nas transições da roda para a mesa e do parque para a saída.

Sua tarefa: desenhe ou descreva, em cada quadro, o símbolo que usaria (foto? pictograma? objeto?) e numere a ordem. Marque com ★ os dois momentos que merecem apoio extra (aviso prévio + timer).

1. _____	2. _____	3. _____
4. _____	5. _____	6. _____

Verifique seu próprio plano

- ☐ O horário ficará na **altura dos olhos** de João e ele poderá manipulá-lo (retirar/virar o cartão concluído)?
- ☐ O **nível simbólico** escolhido é o que João já compreende hoje (foto), e não o que gostaríamos que compreendesse?
- ☐ As duas transições difíceis têm **aviso prévio + timer visual**?
- ☐ Existe um cartão de **“surpresa/mudança”** para imprevistos (professora faltou, chuva no parque)?
- ☐ Alguém definiu **como medir** se funcionou (ex.: crises por semana nas transições marcadas)?

Critérios de resposta comentados na p. 28.

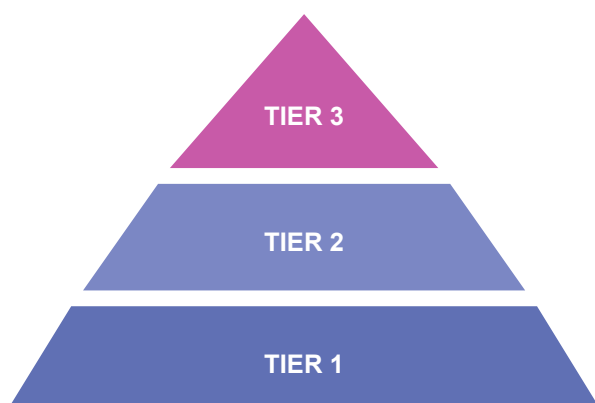
PARTE 2 · ABORDAGEM 3 DE 3

PBS — Suporte Comportamental Positivo

— PBS · FUNDAMENTOS

Prevenir em *três camadas*, com dignidade

O **PBS** (Positive Behavior Support) aplica a ciência da ABA com um compromisso explícito: melhorar a **qualidade de vida** da pessoa e de quem convive com ela, prevenindo comportamentos-desafio em vez de apenas reagir a eles — e **sem punição ou coerção como estratégia**. Nas escolas, sua versão sistêmica é o **PBIS** (EUA, Center on PBIS), organizada em três camadas:



Tier 1 · Universal — para todos

Regras claras e visuais, rotinas previsíveis, elogio frequente ao comportamento esperado, ambiente acolhedor. Previne a maior parte dos problemas.

Tier 2 · Direcionado — para alguns

Apoios em pequeno grupo para quem precisa de mais: check-in/check-out diário, ensino de habilidades sociais, mentoria.

Tier 3 · Individual — para poucos

Avaliação funcional (FBA) e **plano de suporte individualizado**, com equipe e família (próxima página).

Valores inegociáveis do PBS (APBS)

- **Centrado na pessoa e na família** — metas que importam para a vida dela, decididas com ela;
- **Prevenção primeiro** — mudar contextos que produzem o problema, não “consertar a criança”;
- **Ensinar habilidades substitutas** — todo plano reduz um comportamento ensinando outro que funcione melhor;
- **Decisões por dados** — inclusive dados de *fidelidade*: os adultos estão aplicando o combinado?;
- **Dignidade sempre** — nada de humilhação, dor ou contenção como rotina educativa.

✦ NA PRÁTICA

Um bom Tier 1 de sala de aula segue a proporção de **mais reconhecimento do que correção** (recomendação clássica do PBIS: cerca de 4 interações positivas para cada corretiva) — bom para o aluno com TEA e para a turma inteira.

— PBS · MÉTODO

O plano de *suporte comportamental*

No Tier 3, a equipe (escola + família + terapeutas) constrói um plano escrito com **cinco blocos**. Veja aplicado a um caso:

Lucas, 14 anos, nível 1 (exemplo didático fictício)

Lucas responde com agressividade verbal quando corrigido na frente da turma. A FBA mostra: correção pública (antecedente) → explosão verbal (comportamento) → sai da sala / colegas riem (consequências que mantêm: fuga da exposição + reação da audiência).

Bloco do plano	No caso do Lucas
1 · Hipótese funcional por que acontece	Escapar da exposição social da correção pública (fuga) — não “falta de educação”.
2 · Prevenção mudar antecedentes	Feedback passa a ser individual e discreto (código combinado: professor toca na própria orelha = “conversamos depois”); tarefas com nível de desafio ajustado.
3 · Ensino de substitutos o que fazer no lugar	Lucas aprende e ensaia usar o cartão-pausa (sair 5 min para se regular <i>antes</i> da explosão) e frases de autodefesa adequadas (“posso falar com você em particular?”).
4 · Resposta combinada se ocorrer mesmo assim	Adulto mantém tom neutro, retira a audiência (não o aluno, quando possível), retoma o combinado depois da calma. Sem sermão público, sem suspensão automática.
5 · Monitoramento como saber se funciona	Registro semanal: nº de explosões, nº de usos do cartão-pausa e checklist de fidelidade dos professores. Meta: 3 semanas seguidas sem incidente com uso autônomo do cartão. Revisão mensal com Lucas presente.

CONTENÇÃO FÍSICA NÃO É PLANO

Contenção/isolamento só se admitem como **protocolo excepcional de segurança** diante de risco imediato e grave — nunca como consequência educativa ou rotina. Se um serviço usa contenção com frequência, o plano falhou e deve ser reformulado (APBS; princípios da LBI sobre dignidade).

O DETALHE QUE MUDA TUDO

Adolescentes participam do próprio plano. Lucas escolheu o código discreto e o design do cartão — autonomia é reforçador poderoso nessa idade e um direito.

— PBS · FIXAÇÃO

Exercício 3 — *verdadeiro ou falso + mini-plano*

EXERCÍCIO 3

Parte A — julgue as afirmações (V ou F)

- () 1. No PBS, a primeira pergunta diante de um comportamento-desafio é “qual consequência aplicar?”.
- () 2. Todo plano de suporte deve ensinar uma habilidade substituta que atenda à mesma função do comportamento.
- () 3. Dados de fidelidade medem se a *criança* está obedecendo ao plano.
- () 4. Retirar o aluno da sala a cada crise pode, sem querer, reforçar comportamentos de fuga.
- () 5. O Tier 1 do PBIS só se aplica aos alunos com diagnóstico.

EXERCÍCIO 3

Parte B — monte o mini-plano

Cenário: Alice, 9 anos, nível 2, esconde-se embaixo da mesa e cobre os ouvidos toda vez que a turma vai ao refeitório (barulhento e imprevisível). Voltar para a sala é o único “alívio” que ela conhece.

Hipótese de função (por que ela se esconde?):

Prevenção (o que mudar no ambiente/rotina antes do refeitório?):

Habilidade substituta (o que ensinar a Alice para pedir/obter alívio de forma adequada?):

Como medir (que dado simples mostraria progresso em 4 semanas?):

Gabarito comentado na p. 28. Dica: pense em fones abafadores, sair 5 minutos antes com um colega, e no cartão de pausa.

NORMA

Adaptações como sair mais cedo para o refeitório ou usar abafadores são **adaptações razoáveis** garantidas pela LBI (Lei 13.146/2015) — a escola não pode negá-las nem cobrar por elas (ver p. 24).

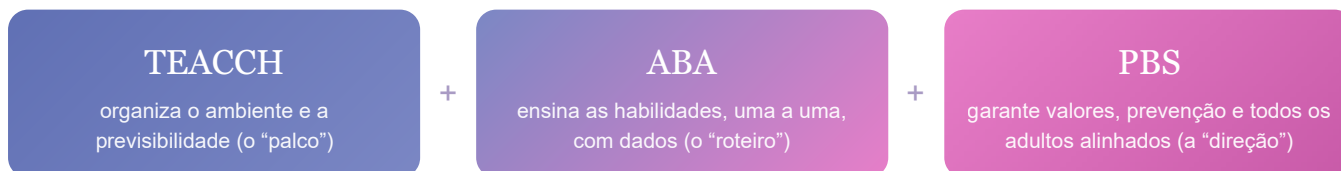
— SÍNTESE DA PARTE 2

ABA × TEACCH × PBS — *comparar para integrar*

Critério	ABA	TEACCH	PBS
Foco principal	Ensinar habilidades e compreender funções do comportamento	Estruturar ambiente e informação visual	Prevenir comportamentos-desafio e elevar qualidade de vida
Base	Ciência do comportamento (Baer, Wolf & Risley, 1968)	“Cultura do autismo” — forças visuais (Schopler, UNC, 1972)	Ciência ABA + valores de direitos e inclusão
Evidência	Alta — maior corpo de pesquisa em TEA	Moderada (AAP, 2020) — forte em engajamento e independência	Alta para FBA + planos funcionais (NCAEP; Center on PBIS)
Cenário típico	Clínica + casa + escola (1:1 e naturalista)	Escola e ambientes coletivos; todos os níveis (essencial no 3)	Escola e comunidade; sistêmico (Tiers) e individual
Intensidade	Focada 10–25 h/sem · abrangente 26–40 h/sem (CASP, 2020)	Contínua — o ambiente inteiro é a intervenção	Contínua no Tier 1; individual no Tier 3
Quem conduz	Analista qualificado + técnicos supervisionados	Equipe escolar/clínica treinada em Ensino Estruturado	Equipe multidisciplinar + família + a própria pessoa
Documentação-chave	Dados por sessão e gráficos	Rotinas e sistemas visuais atualizados	Plano de suporte + dados de fidelidade

Elas não competem — se combinam

Na prática de qualidade, as três convivem na mesma criança e no mesmo dia:



★ NA PRÁTICA — EXEMPLO INTEGRADO

Sala com rotina visual e cantinho da calma (**TEACCH**) + programa de comunicação funcional com dados diários (**ABA**) + regras da turma ensinadas e elogiadas, plano individual com a família e zero correção pública (**PBS**). É exatamente essa integração que as diretrizes internacionais descrevem como cuidado de qualidade.

PARTE 3

O ecossistema de evidências

— CAPÍTULO 3

Outras práticas *com evidência*

Prática	Para quê	Evidência
NDBI / ESDM (Denver precoce)	Intervenção precoce naturalista: une ABA e desenvolvimento, no brincar, com os pais	Alta para primeira infância (NCAEP; NICE)
PECS	Comunicação por troca de figuras em 6 fases — do pedido à comentação	Alta para pedidos funcionais (NCAEP)
CAA de alta tecnologia	Pranchas dinâmicas e apps com voz para comunicação ampla	Recomendada (ASHA); crescente
Intervenções mediadas por pais	Pais treinados aplicam estratégias na rotina — multiplica horas de aprendizagem	Alta (NCAEP; NICE CG170 recomenda expressamente)
Vídeo-modelação	Aprender habilidades sociais e de autonomia vendo vídeos-modelo	Alta (NCAEP)
Histórias sociais	Preparar para situações novas descrevendo o que esperar e o que fazer	Moderada — usar <i>junto</i> com outras práticas (NCAEP)
Mediação por pares	Colegas treinados iniciam e sustentam interações na escola	Alta (NCAEP)
Exercício físico regular	Autorregulação, sono, comportamento e saúde geral	Com evidência (NCAEP)

⚠ **MITO PERIGOSO: “CAA ATRASA A FALA”**

Falso. A posição da ASHA e a literatura indicam o contrário: comunicação alternativa **apoia** o desenvolvimento da fala e reduz frustração. Proibir gestos, figuras ou dispositivo “para forçar a fala” causa sofrimento e atraso — e nega um direito de comunicação.



IMAGEM — criança usando prancha de comunicação ou tablet com símbolos, apontando com adulto ao lado

Busca: “child AAC communication board tablet pointing” (Adobe Stock/Freepik)

— CAPÍTULO 3

O que *evitar* — sem evidência ou com risco

Famílias recebem ofertas constantes de “soluções”. Estas são as principais práticas que as diretrizes mandam **evitar** — por ineficácia comprovada, por risco direto, ou ambos:

Prática	O que dizem as evidências	Risco
“Comunicação facilitada” (facilitador segura a mão que aponta)	Desmascarada em estudos controlados: as mensagens vêm do facilitador. Contraindicada por ASHA e entidades científicas.	Falsa voz atribuída à criança; casos graves de acusações falsas
Dióxido de cloro / “MMS” e afins	Sem qualquer plausibilidade ou evidência; substância corrosiva vendida como “cura”.	Intoxicação grave — alerta de agências sanitárias (Anvisa/FDA)
Quelação (remoção de “metais pesados”)	Premissa falsa (TEA não é intoxicação); sem eficácia demonstrada.	Risco de eventos graves, incl. óbitos relatados
Dietas restritivas (glúten/caseína) sem indicação clínica	Sem evidência de efeito sobre sintomas nucleares (AAP, 2020; NICE). Diferente de tratar alergia/intolerância diagnosticada.	Déficits nutricionais em crianças já seletivas
Câmara hiperbárica para TEA	Sem evidência de benefício para o TEA.	Custo alto; eventos adversos; falsa esperança
Qualquer pacote que prometa “cura”	TEA não é doença a ser curada; o objetivo legítimo é desenvolvimento, comunicação, autonomia e bem-estar (OMS).	Dano financeiro e emocional; atraso das intervenções eficazes

Cinco perguntas que desarmam promessas

1. Quais **estudos independentes** sustentam isso? Pode me enviar?
2. O que exatamente melhora, **em quanto tempo**, e como mediremos?
3. Quais os **riscos e efeitos colaterais** conhecidos?
4. Por que as diretrizes (OMS, AAP, NICE) **não recomendam** este método?
5. Você aceita que eu converse com a **equipe que já atende** meu filho antes de decidir?

💡 ACOLHER, NÃO CULPAR

Famílias que tentaram práticas sem evidência não devem ser envergonhadas — foram, quase sempre, mal informadas em um momento de vulnerabilidade. O papel do profissional é acolher e reorientar com respeito.

— CAPÍTULO 3

Diretrizes internacionais *em uma página*

Fonte (verificada)	Recomendações-chave	Como usar no dia a dia
OMS Resolução WHA67.8 (2014); ficha técnica sobre autismo (2023); programa CST	Cuidado integrado à comunidade; foco em funcionalidade e participação (modelo CIF); treinamento de habilidades de cuidadores (CST) como estratégia escalável.	Envolve a família como agente da intervenção — não como espectadora. Meça participação na vida real, não só sintomas.
NICE — CG170 Reino Unido, 2013, atualizada em 14/06/2021	Intervenções psicossociais com mediação de pais/cuidadores para comunicação social; não usar medicação para os sintomas nucleares do TEA; não usar dietas de exclusão para sintomas nucleares.	Medicação trata comorbidades específicas (quando indicada por médico) — nunca “o autismo em si”. Desconfie do contrário.
AAP Hyman, Levy & Myers, <i>Pediatrics</i> , 2020	Triagem universal aos 18 e 24 meses (M-CHAT-R/F); iniciar intervenção na suspeita ; intervenção precoce intensiva e coordenação do cuidado; atenção às comorbidades (sono, GI, epilepsia, saúde mental).	Não aguarde fila de diagnóstico para começar estimulação e orientação familiar. Rastreie sono e alimentação em toda consulta/reunião.
NCAEP Hume et al., <i>JADD</i> , 2021	28 práticas baseadas em evidências (a maioria de base comportamental/naturalista) após revisão de 972 estudos (1990–2017).	Ao planejar qualquer meta, escolha a prática da lista NCAEP que melhor se ajusta — e descarte o que não está em nenhuma lista de evidência.
DSM-5-TR APA, 2022	Critérios diagnósticos atuais; especificadores (nível de suporte, linguagem, DI, catatonia...).	Exija laudos com especificadores completos — eles orientam o plano (ver p. 5).

 NOTA DE VERIFICAÇÃO

Estas cinco referências foram **verificadas em julho/2026** nas fontes oficiais (links na p. 30). Diretrizes são revisadas periodicamente: ao citar em documentos oficiais do serviço, confira a versão vigente no site do emissor.

Diretriz boa é a que muda decisão: quem triar, quando começar, o que oferecer — e o que recusar.

PARTE 4

Direitos e normas no Brasil

— CAPÍTULO 4 · LEGISLAÇÃO

As leis que *protegem* a pessoa com TEA

Lei	O que garante na prática
Lei nº 12.764/2012 "Lei Berenice Piana"	Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com TEA. Pessoa com TEA é pessoa com deficiência para todos os efeitos legais ; direito a diagnóstico precoce, tratamento multidisciplinar e acesso à educação; em caso de comprovada necessidade , direito a acompanhante especializado na classe comum (art. 3º, parágrafo único).
Lei nº 13.146/2015 Lei Brasileira de Inclusão (LBI)	Educação inclusiva como regra; adaptações razoáveis e tecnologia assistiva; proibição de cobrança de valores adicionais por adaptações (art. 28, §1º); atendimento prioritário; direito à habilitação/reabilitação. Vale para escolas públicas e privadas.
Lei nº 13.977/2020 "Lei Romeo Mion"	Cria a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com TEA), gratuita, para garantir atendimento prioritário e comprovar a condição sem exigir laudo a cada atendimento.
Lei nº 7.853/1989, art. 8º (redação dada pela LBI)	Recusar, cobrar a mais ou dificultar matrícula de aluno com deficiência é crime : reclusão de 2 a 5 anos e multa, em qualquer escola.

✦ NA PRÁTICA — CENA REAL DE SECRETARIA

"Já temos muitos alunos de inclusão este ano" **não é resposta legal** — é indício de crime. A família pode registrar boletim de ocorrência, acionar o Ministério Público e a Secretaria de Educação. Escolas sérias mantêm um exemplar da LBI na secretaria e treinam a equipe de matrículas.



IMAGEM — família com criança em ambiente escolar acolhedor / mãos segurando a CIPTEA

Busca: "inclusive school family child welcome brazil" (Freepik) — se possível, foto autorizada de família atendida (LGPD: consentimento por escrito)

— CAPÍTULO 4 · ACESSO

SUS, planos de saúde e escola — *o que cobrar*

No SUS

- **Linha de Cuidado para Atenção às Pessoas com TEA** (Ministério da Saúde, 2013): organiza o percurso — atenção básica → CER/especializada → RAPS quando necessário;
- **Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 7/2022**: aprova o PCDT do *Comportamento Agressivo no TEA* (critérios para uso de risperidona e manejo). Atenção: este PCDT trata **especificamente de comportamento agressivo** — não é um protocolo geral de terapias do TEA;
- Habilitação/reabilitação nos **CER** (Centros Especializados em Reabilitação) e estimulação precoce na rede.

Nos planos de saúde (ANS)

- **RN nº 469/2021**: fim do limite de sessões de fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional e fisioterapia para beneficiários com TEA — **sessões ilimitadas** conforme prescrição;
- **RN nº 539/2022**: o plano deve cobrir **qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente** para transtornos globais do desenvolvimento — incluindo ABA e abordagens deste guia;
- Negativa? Peça a **recusa por escrito**, abra **NIP na ANS** (0800 701 9656 / ans.gov.br), e procure Procon ou Defensoria. Guarde prescrições e protocolos.

Na escola

- **Decreto nº 7.611/2011**: estrutura o AEE (Atendimento Educacional Especializado) e as salas de recursos multifuncionais;
- **Nota Técnica nº 24/2013/MEC/SECADI/DPEE**: orienta os sistemas de ensino na implementação da Lei Berenice Piana — AEE, acompanhante, formação de professores;
- **Nota Técnica nº 04/2014/MEC/SECADI/DPEE**: laudo médico **não é pré-requisito** para AEE;
- Exija o **PEI** (Plano Educacional Individualizado) escrito, com metas, adaptações e responsáveis — e revisão periódica com a família.

CUIDADO COM CITAÇÕES DESATUALIZADAS

Circulam materiais citando normas inexistentes ou revogadas (ex.: resoluções profissionais que não constam nos sites oficiais, ou o Decreto 10.502/2020, **suspenso pelo STF**). Antes de citar norma em documento oficial, confira no site do órgão emissor — foi o que fizemos neste guia (p. 30).

PARTE 5

Caixa de ferramentas

— PARA IMPRIMIR E USAR

Checklist do *educador* e do *terapeuta* **Educador — minha sala está pronta?**

- ☐ Áreas da sala **delimitadas** e com função clara; distratores reduzidos perto do trabalho
- ☐ **Horário visual individual** no nível simbólico certo (objeto/foto/pictograma/palavra), manipulável pelo aluno
- ☐ Transições com **aviso prévio + timer visual**; cartão “surpresa” para imprevistos
- ☐ Instruções **curtas, literais e visuais**; evito ironia e duplo sentido
- ☐ Mais reconhecimento que correção ($\approx 4:1$); **nenhuma correção pública**
- ☐ Cantinho da calma disponível — e **nunca usado como castigo**
- ☐ **PEI** escrito, com metas e adaptações, revisado com família e AEE
- ☐ Registro simples de comportamento (frequência/contexto) para decisões
- ☐ Comunicação alternativa do aluno **disponível o tempo todo**

 Terapeuta — meu caso está bem conduzido?

- ☐ Avaliação inicial com **instrumentos padronizados** (VB-MAPP, ABLLS-R, Vineland-3...)
- ☐ **FBA concluída antes** de qualquer plano de redução de comportamento
- ☐ Metas **funcionais e priorizadas com a família**; consentimento documentado
- ☐ **Assentimento da criança** observado (sinais de estresse = revisar)
- ☐ Dados registrados na grande maioria das sessões; **gráficos atualizados**
- ☐ Supervisão do caso **frequente e documentada**
- ☐ Retorno estruturado à família com gráficos (sugestão: quinzenal)
- ☐ Plano de **generalização** (escola/casa) escrito — não deixado ao acaso
- ☐ Integração com a escola: metas compartilhadas com professor e AEE

 COMO USAR

Imprima esta página e a seguinte. Marque semanalmente: itens sem ✓ por duas semanas seguidas viram **pauta de reunião de equipe** — não culpa individual.

— PARA IMPRIMIR E USAR

Checklist do *gestor* e da *família*

Gestor — meu serviço está em conformidade?

- ☐ Plano anual de **formação continuada** da equipe (sugestão: ≥ 40h/ano em práticas baseadas em evidências)
- ☐ **Fidelidade de implementação** medida periodicamente (observação com roteiro)
- ☐ Prontuários completos: avaliações, planos, **consentimentos**, registros de supervisão
- ☐ **LGPD**: dados de saúde de crianças são dados sensíveis — acesso controlado, consentimento para uso de imagem, política escrita
- ☐ Protocolo de crise **sem contenção como rotina**; registro e revisão de todo episódio
- ☐ Conformidade com LBI, Lei Berenice Piana e Romeo Mion (prioridade, acessibilidade, não recusa)
- ☐ Canal estruturado de escuta das famílias (e das próprias crianças/adolescentes)
- ☐ Contratos e materiais **sem promessas de resultado**; publicidade ética

Família — este serviço é de qualidade?

- ☐ Me mostraram uma **avaliação inicial** e um plano escrito com metas que fazem sentido na nossa vida
- ☐ Posso **assistir a sessões** e recebo orientação para aplicar em casa
- ☐ Vejo **gráficos/dados** do progresso, não só “ele foi bem hoje”
- ☐ Meu filho **gosta de ir** — ou, se resiste, a equipe investiga e ajusta
- ☐ As metas incluem **comunicação e autonomia**, não só “ficar quieto”
- ☐ Ninguém prometeu **cura** nem pediu para abandonar as outras terapias
- ☐ A equipe **conversa com a escola** do meu filho
- ☐ Sei **quem supervisiona** o caso e com que frequência
- ☐ Perguntas são bem-vindas — ninguém se ofende quando peço evidências

SINAIS DE ALERTA EM QUALQUER SERVIÇO

Promessa de cura ou prazo garantido · proibição de assistir sessões · ausência de dados · criança sai chorando sistematicamente e “é normal” · pacotes caríssimos pagos à vista · desqualificação de outras equipes. **Dois ou mais sinais: procure uma segunda opinião.**

— EXERCÍCIOS

Gabarito *comentado*

Exercício 1 — funções do comportamento (p. 12)

1. **Lara → T (tangível).** O grito produziu o chocolate. Cada “só hoje” fortalece o comportamento — a saída é ensinar o pedido adequado e sustentar o combinado.
2. **Théo → F (fuga).** Derrubar lápis adia a lição. Intervenção: reduzir a demanda inicial, ensinar pedido de ajuda/pausa e garantir que a lição retorne.
3. **Bia → A (atenção).** A “bronca” é atenção — e os sons aumentaram (efeito do reforço). Atenção deve vir farta quando Bia está engajada, e mínima no som inadequado.
4. **Rafa → S (automática/sensorial).** Ocorre sem audiência e com prazer evidente. Não machuca nem impede participação: **não é alvo de eliminação**; se necessário, oferecer contextos adequados.
5. **Nina:** A = escovação iniciada; B = morder a escova e virar o rosto; C = escovação encerrada → **função de fuga**. Caminho: dessensibilização gradual, escolhas (sabor da pasta, ordem), reforço de tolerância crescente.

Exercício 2 — horário visual (p. 16)

Não há resposta única; um bom plano atende aos critérios: **fotos** (nível que João compreende), ordem espelhando a rotina real (chegada → roda → mesa → lanche → parque → saída), ★ nas transições **roda→mesa** e **parque→saída** com aviso prévio + timer, cartão “surpresa” previsto e uma medida definida (ex.: crises/semana nessas transições). Se você marcou tudo isso no checklist, seu plano está pronto para testar — e ajustar com dados.

Exercício 3 — PBS (p. 19)

Parte A: 1-F (a primeira pergunta é “qual a função?”, não “qual castigo”) · 2-V (princípio central do PBS) · 3-F (fidelidade mede os *adultos*: o plano está sendo aplicado como combinado?) · 4-V (sair da sala pode ser exatamente o reforço da fuga) · 5-F (Tier 1 é universal — para todos os alunos, com e sem diagnóstico).

Parte B (exemplo de resposta): Função: *fuga/esquiva do ambiente sensorialmente aversivo* (ruído + imprevisibilidade). Prevenção: sair 5 min antes com um colega, sentar em mesa mais silenciosa, fones abafadores disponíveis, história social antes do refeitório. Habilidade substituta: pedir pausa/fones com cartão ou fala (“tá alto, posso sair?”) *antes* de se esconder. Medida: nº de idas ao refeitório com permanência ≥ 15 min sem esconder-se, por semana.

💡 CONTINUE PRATICANDO

Refaça os exercícios com casos reais do seu contexto (sem identificar as crianças). Em formações de equipe, use os cenários como dinâmica: cada grupo defende uma hipótese de função **com os dados do registro A-B-C** — é assim que a análise vira cultura.

— CONSULTA RÁPIDA

Glossário

AEE

Atendimento Educacional Especializado — apoio pedagógico complementar (não substitui a classe comum), em sala de recursos.

Assentimento

Concordância da própria criança em participar, demonstrada por comportamento — complementa o consentimento dos responsáveis.

CAA / AAC

Comunicação Aumentativa e Alternativa: gestos, pranchas, PECS, aplicativos com voz.

CIPTEA

Carteira de Identificação da Pessoa com TEA (Lei 13.977/2020), gratuita, garante prioridade.

Contingência A-B-C

Relação Antecedente → Comportamento → Consequência, unidade básica de análise da ABA.

DRA

Reforço Diferencial de comportamento Alternativo: reforçar o substituto adequado enquanto o problema deixa de ser reforçado.

DTT

Ensino por Tentativas Discretas: instrução → resposta → consequência, em passos curtos e repetidos.

Ecolalia

Repetição de falas ouvidas (imediata ou tardia); frequentemente comunicativa — investigue a função.

Esvanecimento (fading)

Retirada gradual de dicas para o aluno responder com autonomia.

FBA / Avaliação funcional

Processo para identificar a função do comportamento (entrevistas, observação A-B-C, análise).

FCT

Treino de Comunicação Funcional: ensinar um pedido que substitui o comportamento-desafio (ex.: cartão de pausa).

Generalização

Usar a habilidade aprendida com outras pessoas, lugares e materiais — deve ser planejada, não esperada.

NDBI

Intervenções Naturalistas do Desenvolvimento e Comportamentais (ex.: ESDM) — ABA + desenvolvimento, no brincar.

PECS

Sistema de comunicação por troca de figuras, em 6 fases.

PEI

Plano Educacional Individualizado: metas, adaptações e responsáveis pelo aluno, revisado periodicamente.

Reforçador

Consequência que aumenta a probabilidade futura do comportamento. É individual: descobre-se testando (pareamento).

Rotina/horário visual

Sequência de símbolos (objeto, foto, pictograma, palavra) que antecipa o que vai acontecer.

Stimming

Autoestimulação (balançar, girar objetos): frequentemente autorregulação — só é alvo se causar dano ou impedir participação.

Tier 1 / 2 / 3

Camadas do PBIS: universal (todos), direcionada (alguns), individualizada (poucos).

— FONTES

Referências *verificadas*

✓ Todas as fontes abaixo foram conferidas nos sites oficiais em **julho/2026**.

1. American Psychiatric Association. *DSM-5-TR — Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais*, texto revisado. APA, 2022.
2. Hume, K. et al. Evidence-Based Practices for Children, Youth, and Young Adults with Autism: Third Generation Review (NCAEP). *J Autism Dev Disord*, 51, 4013–4032, 2021.
3. Behavior Analyst Certification Board. *Ethics Code for Behavior Analysts*. BACB, 2020 (vigente desde 2022). bacb.com
4. Council of Autism Service Providers. *ABA Treatment of ASD: Practice Guidelines for Healthcare Funders and Managers*, 2ª ed. CASP, 2020. casproviders.org
5. NICE. *Autism spectrum disorder in under 19s: support and management* (CG170). 2013, atualizada em 14/06/2021. nice.org.uk/guidance/cg170
6. Hyman, S. L.; Levy, S. E.; Myers, S. M. Identification, Evaluation, and Management of Children With ASD. *Pediatrics*, 145(1), 2020 (AAP).
7. Organização Mundial da Saúde. Resolução WHA67.8 (2014); ficha técnica *Autism* (2023); programa *Caregiver Skills Training* (CST). who.int
8. TEACCH Autism Program — University of North Carolina. teacch.com
9. Association for Positive Behavior Support. *Standards of Practice*. apbs.org · Center on PBIS. pbis.org
10. ASHA — American Speech-Language-Hearing Association. Práticas em CAA (Practice Portal). asha.org
11. Brasil. **Lei nº 12.764/2012** (Berenice Piana); **Lei nº 13.146/2015** (LBI); **Lei nº 13.977/2020** (Romeo Mion); **Lei nº 7.853/1989**, art. 8º. planalto.gov.br
12. Ministério da Saúde. *Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com TEA e suas Famílias*, 2013 · **Portaria Conjunta SAES/SCTIE nº 7/2022** — PCDT Comportamento Agressivo no TEA. gov.br/conitec
13. ANS. **RN nº 469/2021** e **RN nº 539/2022** — cobertura obrigatória e sessões ilimitadas. gov.br/ans
14. MEC. **Nota Técnica nº 24/2013** e **Nota Técnica nº 04/2014** — MEC/SECADI/DPEE · Decreto nº 7.611/2011 (AEE).
15. CDC. Prevalence of ASD — ADDM Network (dados 2022). *MMWR*, 2025. cdc.gov
16. Baer, D.; Wolf, M.; Risley, T. Some current dimensions of applied behavior analysis. *JABA*, 1(1), 91–97, 1968.

**Instituto Flor de Lótus**

Clínica multidisciplinar · 12 especialidades integradas · 10 anos transformando vidas em Sorocaba/SP.

WhatsApp (15) 99182-9151 ·  www.institutoflodelotus.com.br · Portal da Família no site.

© 2026 Instituto Flor de Lótus. Material educativo — pode ser reproduzido para fins educacionais não comerciais, com crédito. Versão 1.0 · Julho/2026 · Revisão técnica: *[pendente]*. Este guia não substitui avaliação profissional individualizada.